

12 - 06- Tumeurs du sein - Pr. Asmouki

J'espère que la préparation va dans le bon sens que vous voulez, bon courage. Aujourd'hui, on va traiter un chapitre très important chez la femme concernant la pathologie du sein. Beaucoup de pathologies peuvent toucher la glande mammaire, glande exocrine dont les rôles sont la nutrition du nouveau-né, de l'enfant.

C'est également un organe qui a une symbolique très importante chez la femme, que ce soit pour le désir sexuel, que ce soit pour l'esthétique. C'est un organe très important chez l'homme. Pourquoi ce chapitre est important à connaître? La grande crainte du médecin, c'est de se retrouver face à une femme qui a un cancer du sein.

C'est ça la grande crainte, le cancer du sein. Sa vision de la part de la population féminine est très péjorative. C'est un synonyme de la mort, d'autant plus que ce cancer est très fréquent, très fréquent.

On peut dire qu'une femme sur 8 ou bien une femme sur 9 va faire un cancer du sein au cours de sa vie, va vraiment faire un cancer du sein. D'où l'importance de cette pathologie. L'autre chiffre qui est important à connaître, c'est que sur les nouveaux cas de cancer du sein chez la femme, lorsqu'on prend une année, par exemple 2020 au Maroc, 38% des cancers découverts chez la femme, 38% de tous les cancers découverts chez la femme, ce sont des cancers du sein.

C'est le premier cancer chez la femme, une femme sur 8, ça c'est plus de un tiers des nouveaux cas de cancer, ce sont des cancers du sein. Même si on prend l'homme et la femme, pour les statistiques, un cancer sur 5 c'est un cancer du sein. Jusqu'à 20% de tous les cancers, si on prend les deux sexes.

Si on prend que la femme, 38% de nouveaux cas de cancer sont des cancers du sein. L'autre chose à comprendre, c'est que le diagnostic précocement, la guérison est supérieure à 95%. Si le diagnostic est au tout début, le traitement est facile, pas très agressif et le pronostic est excellent.

Si on le trouve dans les formes très très précoces, c'est ça l'objectif du dépistage. D'ailleurs le mois d'octobre, c'est le mois du cancer du sein, décrété par l'OMS comme le mois de sensibilisation pour prévenir contre la survenue du cancer du sein. Donc, heureusement qu'il n'y a pas que le cancer du sein qui intéresse le sein, il y a d'autres pathologies.

On va les voir rapidement, mais on va essentiellement axer notre cours sur les particularités diagnostiques et thérapeutiques du cancer du sein. Je vais commencer ce cours par un cas que je viens de prendre en charge très récemment, mais pas deux semaines. Une femme qui a palpé un ondule au niveau de son sein droit.

Parmi les circonstances de découverte, vous avez trouvé une découverte à l'autopalpation. Elle a

38 ans, elle est très jeune. Elle a deux enfants.

Elle a 38 ans et elle a palpé une boule au niveau de son sein que j'ai entourée avec un marqueur. C'est une boule au niveau des cadrans supérieurs. Toujours quand on trouve une masse, il faut la situer par rapport au sein.

Là, si on peut la situer, c'est à la jonction des deux cadrans supérieurs du sein droit qui mesure environ 2,5 cm et qui l'a amené à faire une consultation. 38 ans, deux enfants vivants, à l'autopalpation, elle a un ondule. De quoi il peut s'agir? De quoi il peut s'agir? Quelles sont les hypothèses diagnostiques? Un kyste.

Très bien, il peut s'agir d'un kyste. Quoi? Il peut s'agir d'un adenofibrome. Très bien, ça peut être un adenofibrome.

Ça peut être un kyste. Ça peut être également quoi? Quoi? Une tumor fill load. Ça peut être une tumor fill load.

Ça peut être un cancer. Alors, j'évoquerai quoi en premier lieu? Vu la gravité, vu la fréquence, pas parce qu'il est plus fréquent que les adenofibromes, mais par fréquence, je dois penser au cancer, vu que c'est une situation qui est très fréquente, en premier. Mais il peut s'agir d'un kyste.

Donc, cliniquement, est-ce que je peux faire la part des choses entre un cancer et un adenofibrome ou une tumor fill load ou un kyste? On peut cliniquement, déjà, dans certains aspects, l'aspect dur, l'irrégularité, ou bien l'aspect mou, réunitant, ou bien le fait que ça soit mobile et bien limité. Donc, cliniquement, on peut avoir plus un diagnostic que d'autres. Je trouve que c'est une masse qui est bien limitée, ronde, mobile, par rapport aux deux plans, et qui est réunitante à l'aspect liquidien.

Je vais commencer par un kyste, mais je vais toujours évoquer le cancer. Donc, on a évoqué le kyste. On a évoqué les adenofibromes, les tumeurs bénignes.

On a évoqué les tumeurs fill load, les tumeurs qui sont soit bénignes, soit malignes. On va aller voir. On a évoqué le cancer.

Quel est le type de cancer qui est le plus fréquent? L'adénocarcinome. Donc, on peut avoir un adénocarcinome. Qu'est-ce qu'on peut également évoquer? On peut évoquer un ganglion, un trauma mère.

On peut évoquer ce qu'on veut à l'étape clinique et à l'examen. On peut évoquer d'autres pathologies qui sont fréquentes. Les lymphomes.

On peut avoir un lymphome. On peut avoir une masse qui se présente. Il y a beaucoup de cas de postère.

On pensait à un cancer. La biopsie, on a trouvé que c'était un lymphome. Le lymphome, le traitement, c'est essentiellement la chimiothérapie.

Alors que le cancer, c'est une réunion de concertation pluridisciplinaire où il y a une stratégie thérapeutique à adopter. Donc, on a évoqué tous les diagnostics. Il reste d'autres diagnostics qu'il faut toujours évoquer au Maroc.

Au Maroc, la tuberculose. Il y a des formes pseudo-tumorales de la tuberculose mammaire. Des formes qui se présentent comme un cancer.

Et c'est une découverte à la biopsie. La biopsie, on vous dit qu'il y a un granulome épithélio-giganto-cellulaire avec nécrose caséuse et qu'on est soulagé lorsqu'on trouve un diagnostic. C'est dans les rares cas où, lorsqu'on trouve la tuberculose, lorsqu'on parle pour une suspicion de cancer, qu'à la biopsie, on nous répond tuberculose.

Donc, c'est pour cela que le terme biopsie va toujours revenir. Et la biopsie, elle est très importante. La confirmation histologique, elle est très importante.

Alors, on a évoqué tous ces diagnostics. Ça peut être un lipome, ça peut être un angiosarcome, ça peut être une tumeur. Donc, on peut évoquer tous les autres diagnostics.

Donc, à ce stade-là, tout est permis. On a la crainte du cancer, mais on va tout permettre. On va tout évoquer.

Alors, qu'est-ce qui va nous aider? Quel est le premier examen à demander dans ce cas-là? On a fait l'examen clinique. C'est un module plus ou moins bien limité. On ne peut pas écarter aucun des diagnostics qu'on a évoqués.

Qu'est-ce qu'on va demander en premier lieu? L'échographie mammaire. Vous êtes d'accord? Le couple, l'écho. Maman, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est d'emblée pour la maman? Selon l'âge, elle est jeune.

Elle est très jeune. Qui dit jeune, dit sain, très dense. Donc, la mammographie va être difficilement interprétable.

Le premier examen dans ce cas-là, ça va être une échographie. Donc, on a fait l'échographie. Qu'est-ce qu'on a trouvé? C'est un cas réel que je viens de voir.

Un module qui n'est pas liquidien. Donc, le kyste est parti. Qui n'est pas adénofibrant parce que l'ondule est... Quoi? Comment? Voilà l'ondule.

Une échographie mammaire. Qui est irrégulière. C'est angulaire.

Ce n'est pas bien limité. Alors que l'adénofibrant... Comment dire? Est-ce qu'il est anécogène,

époécogène, hyperécogène? Elle est époécogène par rapport au reste de la glande mammaire. Et il y a un petit renforcement postérieur.

Vous voyez que les échos derrière... Il y a de l'eau blanche. Ce sont des échos. Donc, il y a des échos qui ont été consommés pour avoir... On a plus traversé facilement l'ondule pour avoir une accentuation postérieure.

Dans le kyste, on va avoir beaucoup d'accentuations. Là, c'est un peu époécogène. On a moins... Si c'est quelque chose de très dur, un calcul, on va avoir un compte d'ombres derrière.

Ça, c'est juste un petit rappel de la simbiologie radiologique. Donc, un truc irrégulier. Dans ce cas-là, normalement, quand on fait l'échographie, c'est en anglais, c'est une femme qui est suivie dans un pays arabe et qui est venue pour faire son traitement au Maroc.

Alors, right breast suspicious mass, mass droite suspect, Bayrad 5. C'est un Bayrad 5. Vous avez fait la simbiologie radiologique du sein. Normalement, en quatrième année, on fait la simbiologie du sein. D'ailleurs, sur l'homographie et sur l'échographie.

Je vous invite à un petit peu voir parce que c'est important. Là, vous allez utiliser ce que vous avez vu dans la radiologie, ici. Donc, c'est une image très suspecte.

Donc, il y a Bayrad 1, Bayrad 2, Bayrad 3, 4, 5. 1, 2, c'est bénin. 3, c'est à surveiller. 4 et 5, c'est très suspect.

Il faut faire la biopsie. Donc, l'image hypoécogène et régulière avec un renforcement postérieur. Parfois, c'est pas la mammographie, c'est l'échographie.

Donc ça, c'est très suspect. C'est un Bayrad 5. Il faut que je fasse une biopsie. Est-ce que je dois demander la mammographie? Là, c'est discuté.

Ce n'est pas obligatoire. D'ailleurs, on n'a pas fait la mammographie. Parce que l'échographie a trouvé cette lésion-là et que le reste du sein, le sein contralatéral est très important.

Dans cette échographie, donc déjà dans l'examen clinique, parmi les choses qu'on a oubliées, dont on devait parler à l'examen clinique, il ne faut pas oublier la palpation axillaire. Donc ça, c'est très important. La palpation axillaire est très importante en matière de nodules du sein.

On ne doit pas l'oublier. Bien sûr, avec l'examen général. Et également, l'échographie va nous dire la structure du nodule.

Il va également nous parler de ce qu'il y a des adénopathies axillaires. On va voir ce qui est très important dans la prise en charge par la suite. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit concernant les nodules? Des adénopathies bilatérales réactives axillaire et lymphnodes.

C'est ici. Voilà. Les vaisseaux sont normaux, mais des adénopathies axillaires réactives.

Est-ce que c'est grave? En matière de cancer, non, ce n'est pas grave. Lorsqu'on ne trouve que des adénopathies de moins d'un centimètre, avec une conservation, parce qu'en échographie, l'avantage par rapport à l'examen clinique, il va voir la structure de l'adénopathie. Est-ce qu'il l'a modifiée? Est-ce qu'il n'y a pas le cortex, la médulaire? Est-ce qu'il n'y a pas des excroissances en plus? Dans ce cas-là, il a vu des adénopathies d'aspect normal.

C'est classique de trouver des adénopathies lenticulaires bilatérales. Quand c'est bilatéral, quand c'est inférieur à un centimètre, quand la structure du ganglion est conservée, en général, c'est très rassurant. Donc là, on peut dire qu'il n'y a pas d'adénopathie suspecte.

C'est ça la conclusion. Donc il y a un nodule qui est très suspect. Bayard 5, absence d'adénopathie axillaire.

Avec cette échographie, avec l'examen clinique, avec les diagnostics qu'on a supposés au début, ce qui va être éliminé finalement, on va éliminer le kyste, on va éliminer l'adénofibrome, parce que ça, l'adénofibrome, c'est complètement différent de ça. C'est bien limité. Le grand axe horizontal, très bien visible.

C'est à éliminer dans ce cas-là. La tumeur filotte, c'est également à éliminer. On va voir pourquoi.

La tumeur filotte, en général, c'est comme l'adénofibrome, sur le plan clinique et échographique, sauf que ça évolue plus rapidement que l'adénofibrome. L'adénofibrome a une évolution très lente, alors que la tumeur filotte, parmi les choses qui doivent nous faire suspecter une tumeur filotte, c'est l'évolution rapide. Elle était de 4 centimètres, elle était de 3 centimètres par exemple.

Après un mois, elle va devenir le double ou le triple. La tumeur filotte, c'est très floride. Donc, on a fait l'échographie.

On pense en premier à un cancer, il faut faire la biopsie. Alors la biopsie, comment on va la faire? Est-ce qu'on va faire une biopsie chirurgicale, éco-guidée? Pourquoi éco-guidée? Puisque c'est palpable, pourquoi je vais... C'est palpable, je n'ai pas besoin de l'échographie éco-guidée. Par contre, si c'était une lésion découverte sans nodule qu'on peut palper, dans le dépistage, parfois on trouve des nodules infracliniques.

Dans ce cas-là, il faut un guidage, soit échographie, soit mammographie, soit autre chose. Là, on n'a pas besoin de l'échographie pour guider. Si le nodule était difficilement palpable ou bien non palpable, oui.

Là, c'est un nodule de 2,5 cm. On peut le prendre entre nos doigts et faire notre biopsie. Donc, le nodule est bien palpable, on peut faire la biopsie sans problème.

Alors, voilà, ils ont envoyé la femme pour... Déjà, Boots-Britz Ultrasonographie, donc mammographie, échographie mammaire bilatérale. J'ai caché le nom du médecin. Kindly accept

this case for UIS.

Ils ont demandé un guidage. Normalement, là, c'est un cas que j'ai reçu. Si j'avais vu ça, je n'aurais pas demandé le guidage échographique parce que ça ne sert à rien.

Le nodule est palpable. Nos résidents, tous les jours, font des biopsies de nodules suspects sans faire l'échographie. L'échographie, c'est lorsque c'est non palpable.

Là, on est obligé de faire l'échographie, d'être orienté. On voit l'aiguille entrer dans le nodule et faire notre biopsie. Là, ils ont fait la biopsie.

Je ne suis pas d'accord avec le guidage. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, guide tracute, needle biopsy.

C'est la biopsie tracute guidée par l'échographie. C'est ce qu'ils ont fait. Alors, ils ont fait la biopsie.

Ils ont demandé pathologie. En anglais, quand on demande pathologie, exam, c'est l'anapathie. C'est l'anapathie.

Pathologie, c'est l'anapathie. Ils ont demandé l'anapathie. Alors, quand ils ont accepté la crise, ils ont déjà confirmé le diagnostic.

Ils ont demandé plus d'examens. On va voir. Quand on confirme le diagnostic d'un carcinome, alors, on a fait la biopsie.

Et ils nous parlent d'un carcinome canalaire invasif. Quelle est la prochaine étape? Qu'est-ce que vous avez demandé? Qu'est-ce que vous avez besoin? Vous suivez avec moi le cas depuis le début. On a fait l'échographie.

On a un nodule. On a fait la biopsie. La biopsie nous répond péjoratif.

Elle est positive. C'est un cancer. Ce n'est pas un institut, c'est un invasif.

Premièrement, si c'est un institut, c'est de bons pronostics. Là, c'est invasif. On est déjà dans le cancer invasif.

Carcinome, canalaire, institut. Pour soi, carcinome, parce qu'il y a d'autres types de cancers. Des carcinomes.

Il y a le carcinome globulaire, le carcinome mycineux, papillaire. Il y a beaucoup de types. Ce qui nous intéresse ici, c'est carcinome.

Canalaire, c'est le type histologique. Et invasif. Très important.

Invasif. Ce n'est pas un institut. Déjà, le traitement, ça n'a rien à voir avec celui de l'institut.

Ils ont demandé un complément. Qu'est-ce qu'on va demander comme complément? Est-ce qu'on est obligé de le demander ou non? Est-ce qu'on passe directement au traitement? On va? On ne va demander pas. Très bien.

Donc, à chaque fois qu'on a un diagnostic de carcinome invasif, il faut faire un bilan d'extension. Qu'est-ce qu'on va demander comme bilan d'extension chez cette femme-là? Avant le TAP. Déjà, cliniquement.

La clinique. Voir s'il n'y a pas d'autres adénopathies. Est-ce qu'il y a une spinomygalie? Est-ce qu'il y a une hépatomygalie? Le bilan d'extension, toujours on commence par la clinique.

On passe aux examens plus sophistiqués. La clinique, la femme, elle est à côté de nous. On peut faire ça.

On va dire qu'il n'y a pas d'adénopathie autre que ça. L'autre sein, il n'y a rien. Ça fait partie de l'extension.

Il n'y a pas de spinomygalie. Il n'y a pas d'hépatomygalie. Il n'y a pas d'autres adénopathies.

Ça, j'ai fait l'étape clinique. L'étape imagerie. Maintenant, on a la main facile de demander la tomodensitométrie abdominal-pélvienne.

Le TAP, ça montre le foie. Ça montre les reins. Ça montre le pelvis, les ovaires.

Tout ça, on peut le voir. Il y a le TAP. Quoi encore? La scintigraphie, c'est pour voir s'il y a une atteinte osseuse parce que le TAP ne va pas montrer l'extension osseuse.

Est-ce qu'on la demande systématiquement? Ça, c'est discuté. Vous pouvez la demander. J'aimerais bien que vous la demandiez s'il y a des signes d'appel osseux, s'il y a des douleurs.

Parce que c'est quand même un cas de deux centimètres et demi. Ce n'est pas un T3, T4. Ce n'est pas un cancer T3, T4.

On va aboutir à ça parce que dans le T1, T2, on n'a pas besoin de la scintigraphie. Sauf si la femme vous dit que j'ai une douleur au niveau du bassin ou bien une douleur au niveau de l'épaule osseuse, vous ne trouvez pas de masse, vous allez demander la scintigraphie parce que même une petite lésion peut donner ça. C'est ça, l'autre chose dans le cancer du sein, c'est un groupe très hétérogène.

De point de vue moléculaire, il y a beaucoup de types. C'est pour cela qu'il y a des petits cancers parfois qui se révèlent par la métastase, qui se révèlent par des adénopathies. Parfois, on a une grosse tumeur et il n'y a pas de métastase.

Donc, il y a beaucoup de types de cancers du sein. Ce qui est important, c'est la clinique. Il y a d'autres éléments qu'on va voir également à l'échographie.

On va dire que l'autre sein, il n'y a rien à l'échographie. Ou bien la mammographie, ça a été fait. On voit si l'autre sein, il y a quelque chose.

Et le TAP, c'est l'examen que vous devez demander en premier. Et la scintigraphie ou bien le scanner cérébral, en fonction, est-ce qu'il y a des signes cliniques d'appel. Je demande ces examens-là pour voir si c'est métastatique.

Donc, bilan d'extension. Qu'est-ce qui reste? Est-ce qu'ils sont obligatoires? Quel type de récepteurs hormonaux? Les oestrogènes? La progestérone? Quoi? Vous êtes d'accord avec l'HER2? L'HER2? Le KI67. On le demande systématiquement.

Maintenant, vu cette grande hétérogénéité des carcinomes, il faut essayer de les cadrer dans un sous-groupe particulier. D'une part, il faut connaître le type moléculaire. On va demander l'immunohistochimie.

C'est obligatoire. Ça se fait par immunohistochimie. Quoi encore? Alors, c'est ce qu'ils ont demandé ici.

If malignant, si c'est malin, parce que la biopsie a été faite, on ne sait pas si c'est une tuberculose, un lymphome, un carcinome. Ils ont dit pathologie. If malignant, œstrogène récepteur, progestérone récepteur, HER2 receptor, KI67.

Ils font la même chose que nous. C'est la recommandation. Il faut tout faire.

Qu'est-ce qu'ils ajoutent à la fin? C'est une patiente de 38 ans. La biopsie est faite pour right breast malignant nodule. Ils ont le carcinome.

Si c'est positif, il faut demander le récepteur, l'HER, le KI67. On est d'accord. On est d'accord jusqu'à présent.

On a fait le bilan d'extension. On a demandé le récepteur. Quelle est la prochaine étape? La prochaine étape? Chimiothérapie, radiothérapie, chirurgie.

Les traitements qu'on peut proposer. Chimiothérapie, radiothérapie, chirurgie. Quoi encore? L'hormonothérapie.

D'ailleurs, c'est pour cela qu'on a demandé le récepteur. Qu'est-ce que ça peut être également? La thérapie ciblée, les anticorps. Quoi encore? On va commencer par quoi? Il faut classer.

On a assez d'éléments pour classer. Il faut donner un TNM pour cette tumeur. Comment on peut classer cette tumeur-là? C'est un carcinome.

On peut parler de TNM. À l'examen clinique, on a parlé de nodule suspect. On ne peut pas parler de TNM tant qu'on n'a pas confirmé.

Si c'est une tuberculose, je vais parler de TNM. Donc, une fois qu'on a confirmé, maintenant on va classer pour justement la cadrer dans quelle stratégie thérapeutique on va adopter. Alors, si on veut classer cette femme-là, 2,5 cm, c'est quel T? En général, le TNM, c'est la clinique.

En fait, c'est un petit c, TNM. Clinique, TNM. Quand on fait petit p, TNM, c'est après p, pathologie.

C'est là la patte. Après la pathologie, parfois le nodule est mesuré 3 cm à l'examen clinique. Mais à l'examen histopathologique, c'est 1,5 cm.

Ça passe d'un c, T2, à un p, T1. On va voir la classification. T1, entre 0 et 2 cm.

Entre 0 et 2 cm, c'est un T1. Plus de 2 cm, ça devient un T2. Entre 2 et 5 cm, c'est un T2.

Plus de 5 cm, c'est un T3. La classification du sang est très compliquée, mais je vais vous faciliter les choses à comprendre. Entre 0 et 2 cm, c'est un T1.

Entre 2 et 5 cm, c'est un T3. Plus de 5 cm, c'est un T4. Et T4, c'est quoi? Tout ce qui n'est pas T4, c'est un T3.

C'est une classification que les médecins doivent connaître. Parce que ça fait partie du traitement. C'est quoi T4? Alors, T4, c'est 4. T4A, T4B, T4C et T4D.

T4A, c'est la paroi thoracique. L'ondule est fixée à la paroi thoracique. Quand vous avez l'ondule, vous arrivez à la mobiliser par rapport à la peau.

Si vous essayez de faire des manœuvres pour voir s'il est fixé à la paroi thoracique, il est fixé. Donc, c'est à la T4A. T4B, il est fixé à la peau.

A, c'est la paroi thoracique. B, c'est la peau. C, c'est les deux.

Fixé à la paroi thoracique et à la peau. D, c'est inflammatoire. Rouge.

Inflammatoire. Quand on voit un cancer du sein avec un sein rouge, chaud, érythémateux, plus de 30% de la surface du sein, ça devient un T4 quoi? Un T4D. On a l'ondule de 2 cm.

On a de 1 cm. Mais lorsque le sein est inflammé, rouge, plus de 30 cm, ça devient un cancer inflammatoire. Cancer inflammatoire, c'est très mauvais pronostic.

On va voir dans les formes cliniques, les formes inflammatoires, les T4D sont de très mauvais pronostics. Est-ce que c'est OK pour la classification? T1, 0,2. T2, 2,5.

T3, plus de 5. T4, fait 4. T4A, la paroi thoracique. La paroi thoracique est moins péjorative que la tente cutanée. Alors la tente cutanée, c'est la rétraction.

La rétraction, ce n'est pas un T4B. C'est l'ulcération. L'ondule avec l'ulcération de la peau.

Parce qu'une ulcération, une destruction d'une petite partie de la peau pour dire un T4B. T4C, c'est la paroi et la peau. T4D, c'est inflammatoire.

C'est pour la tumeur. C'est facile à apprendre. Les gonglions.

N0, N1. N2, N1, N2, N1, N3. Vous n'êtes pas obligés de les apprendre.

N0, c'est absence d'adénopathie. N1, c'est présence d'adénopathie. N2, c'est une adénopathie fixée.

N2, c'est une adénopathie fixée à la peau. Lorsque c'est mobile, c'est N1. Lorsqu'il n'y a pas de gonglions, c'est N0.

Mais lorsque c'est fixé, c'est N2. On ne peut pas compliquer les choses. Cette femme-là, on peut la classer comment? T2, parce qu'elle a 2,5 cm cliniquement.

N0, c'est l'adénopathie bilatérale non suspecte. Parce que l'échographiste, s'il était suspect, il va dire que c'est des gonglions qui sont suspects. Parce qu'il va voir la forme de l'adénopathie à l'échographie.

Elle est de moins de 1 cm. Lorsqu'une adénopathie garde son île, le radiologiste, l'échographiste, dit que c'est une adénopathie qui est réactionnelle. Il a dit réactionnelle.

Même cliniquement, il n'y avait pas d'ondules. Cliniquement, on peut dire que c'est N0. A l'échographie, ça reste un N0.

Donc T2, N0. Pour M, M en fonction du bilan d'extension qu'on a fait. Si le TAP, le TAU, est négatif, s'il n'y a pas de douleur, si l'examen clinique est normal, notre sein, il n'y a rien, c'est un M0.

On va mettre MX si on n'a pas encore les résultats du bilan d'extension. Si cliniquement, vous ne trouvez rien et que le TAP, vous ne l'avez pas encore demandé, vous allez mettre MX. On ne sait pas.

On n'a pas encore la TDM. Donc la classification, c'est un T2 entre 2 et 5 centimètres. N0, il n'y a pas d'adénopathie.

M0, parce qu'on va supposer que le bilan a été fait, il n'y a pas de... J'ai fait des screenshots de ce calage que j'ai trouvé intéressant. Voilà, le résultat de la biopsie. Qu'est-ce qu'elle dit, le résultat de la biopsie? Grosse pathologie.

C'est quoi, grosse pathologie? Macroscopie, hein, macroscopie. Et là, ils ont accepté, ils ont reçu un greyish core. Le trocute, c'est les carottes.

Comment une carotte? Une carotte de 11 millimètres. C'est une biopsie au trocute. Quand vous faites une biopsie chirurgicale, ce n'est pas une carotte.

C'est un fragment. Quand vous lisez l'anapathie, faites attention à ces termes-là. Est-ce que c'est une carotte dans ce calage? C'est une microbiopsie? Ou bien est-ce que c'est un fragment de 3 millimètres, 5 millimètres, 10 millimètres? On donne les trois axes parce que c'est en 3D.

Ils ont reçu un fragment mesurant 3 centimètres sur 4 sur 2. Ça, c'est une biopsie chirurgicale, c'est la chirurgie. La biopsie, on peut le savoir, c'est même si on n'a pas de données, qu'il a été reçu un fragment de 11 millimètres, une carotte de 11 millimètres. Carotte, ça veut dire microbiopsie.

C'est une carotte, un petit carotte. C'est une microbiopsie. 11 millimètres, totale et submitted, qui a été fixée en totalité.

Fixée pour la formule et ils ont cherché pour rechercher est-ce que c'est un cancer ou autre chose. Ils ont conclu qu'il y avait un nombre modéré de méthodiques activités, un composant trajectoire de 25 %. Donc, il y a des composantes intracanales. Pour vous, est-ce que c'est un carcinome? Et ils concluent, il y a toujours la conclusion.

Microscopique diagnosis, infiltration ductale carcinoma grade 3. C'est un cancer ductal. Ductal, il y a un canal. Intracanalé, cancer.

Canalaire, infiltrant ou invasif, c'est la même chose. Infiltrant ou invasif, c'est la même chose. Il a dépassé quoi? La membrane basale.

Donc, il faut faire un bilan d'extension. Infiltrant, c'est qu'il a dépassé la membrane basale. Et ça, c'est juste avant d'avoir demandé les récepteurs, l'HER, le KU.

Donc, ils ont conclu et ils ont demandé un immunophénotype, un immunohistochimie. Ils ont demandé plus pour les récepteurs hormonaux. Les récepteurs hormonaux, on ne peut pas les voir au microscope, pour des colorations spéciales, pour les voir.

Alors là, c'est quoi? C'est le TAP. Multi-slice, CT-chest, abdomen and pelvis, post intravenous contrast study. Finalement, le résultat, il n'y a rien.

Il y a un foie qui est stéatosique. C'est ça le résultat. Il n'y a rien dans l'éthique.

Il n'y a rien. Le bilan d'extension, le TAP, dans ce cas-là, a été normal. C'est pour ça qu'on l'a classé M0.

D'accord? M0. Voilà. Donc, on a le TNM.

D'abord, on peut planifier. On va faire ce qu'on appelle une réunion de concertation pluridisciplinaire. Le cancer du sein, ça se traite en groupe.

Il faut une RCP. On a tous les éléments pour faire la RCP. Il y a les guidelines, il y a les recommandations avec des niveaux de preuves très élevés qu'on peut adopter.

C'est ce qui a été fait chez cette femme-là à l'étranger. Et vous voyez, j'ai beaucoup aimé ce cas-là. Attends, on a le résultat de la RCP.

On arrête. Alors, GERAHA, c'est-à-dire chirurgie première. RELAGE CHIMAOUI, chimiothérapie.

Ils ont tout donné. Parce qu'ils ont tous les éléments pour donner. Je ne sais pas.

RELAGE MOUGE. Alors là, c'est la thérapie ciblée. Pourquoi la thérapie ciblée? Parce que je n'ai pas parlé des récepteurs hormonaux chez cette femme, de l'immunostéochimie.

Ce sont des RH+, c'est-à-dire les récepteurs à l'oestrogène. Les oestrogènes sont positifs. Et les récepteurs à l'oestrogène sont positifs.

Les RH+, ou les oestrogènes, ou la progestérone, on parle de RH+. À partir de 10%, parce que l'expression du résultat des récepteurs hormonaux, c'est le pourcentage. Le pourcentage des cellules tumorales.

Alors, plus de 10%, c'est un RH positif. C'est un récepteur hormonal positif. D'accord? Donc, il est RH+.

L'HER2, il n'arrive pas à dire s'il est positif ou négatif. Quant à l'immunostéochimie, vous avez un HER2 douteux. Il n'est pas trois croix.

Pour dire qu'il est positif, il doit être HER2 trois croix. Quand il y a une croix au laser, c'est négatif. Quand il y a deux croix, qu'est-ce qui l'étape après l'immunostéochimie? La fiche.

C'est ce qu'ils ont dit ici. Plus ou moins, il y a un récepteur hormonal positif. On parle d'un HER2 équivoque, ni positif ni négatif.

Il est équivoque. Il faut faire un autre test d'hybridation pour voir. Parce que c'est très important le statut de l'HER.

Très, très important. Ça change le traitement complètement. Donc, ils ont opté pour la chirurgie première, la chimiothérapie.

Et cette chimiothérapie-là, c'est en fonction des résultats de la fiche. D'accord? C'est en fonction des résultats de la fiche. Troisième étape après la chimiothérapie, la radiothérapie.

Pourquoi la radiothérapie? Ils ont quatre semaines, chaque semaine, cinq séances. C'est la radiothérapie classique. Il y a des protocoles de trois semaines.

Il y a même des protocoles de deux semaines. On augmente la dose, mais on augmente également les effets secondaires. Mais pour vous, en tant que généraliste, quand on fait un traitement conservateur, quand on ne fait pas la mastectomie, est-ce que cette femme-là, on va proposer la mastectomie? Est-ce qu'on va la proposer? Est-ce qu'elle a un T2? Est-ce qu'un T2, on fait la mastectomie? Ce n'est pas aussi facile.

Le standard qu'ils disent, le standard, c'est quoi? Pour un T2 N0, le standard, c'est en premier lieu un traitement conservateur. Un breast conservative surgery. BCS, breast conservative surgery.

Quand vous faites une conservation du sein, c'est-à-dire que vous laissez la glande après le traitement chirurgical, il faut absolument irradier la glande qu'on a laissée. Whole breast radiothérapie, c'est la radiothérapie de tout le sein restant. Il n'y a pas de traitement conservateur, parce que les études ont montré que si vous ne faites pas la radiothérapie, vous avez un risque de récurrence très, très important.

Et même la survie globale est diminuée. Donc, c'est un standard. Traitement conservateur plus radiothérapie, c'est obligatoire.

Donc, j'ai l'AHA, j'ai l'ILEJ-KIMAUI, j'ai l'ILEJ-MOUJEH, j'ai l'ILEJ-ICHAEI. Et après, puisque les récepteurs hormonaux sont positifs, est-ce que c'est logique? Est-ce que vous voyez que cette succession d'événements est logique? Elle est très logique, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on fait, sauf qu'on ne voulait pas. Là, ils ont rassemblé dans une seule feuille pour tracer la décision de la réunion de concertation pluridisciplinaire.

Ça, ça veut dire que cette décision-là, c'est un groupe. Il y a un chirurgien, il y a un oncologue, radiothérapeute, chimiothérapeute. Il y a parfois l'anapath, parfois le radiologue.

Minimum qui est le chirurgien, l'oncologue et le radiothérapeute. Minimum. Pour parler du RCP, il faut au moins trois spécialistes, au moins deux spécialistes.

Parce qu'au Maroc, il y a des radiothérapeutes qui font également de la chimiothérapie. Alors que même, par exemple, à Rabat, soit tu fais de la radiothérapie, soit tu fais de la chimiothérapie. À Gaza, on suit l'école de Gaza, il n'y avait pas de chimiothérapie auparavant.

Il n'y avait pas de chimiothérapeute auparavant. Ce qu'ils font, les radiothérapeutes, dans leur spécialité, c'est radiothérapie et oncologie médicale. Dans leur diplôme.

Ce qui fait que pour la Réunion, on a ça et on suit ça. Et à la fin, qu'est-ce qu'il dit? Follow-up, surveillance. La surveillance, c'est codifié.

Le cancer du sein, quand tu fais tout ça, et surveillance la première année, la deuxième année, quoi, jusqu'à dix ans. Le cancer du sein, on parle de guérison qu'après dix ans. Pourquoi c'est important? Après un an et demi, il n'y a plus rien, il n'y a plus de modules, il est guéri.

Il faut la surveillance. Il faut la surveillance. La surveillance, elle fait partie de la prise en charge.

Si on trouve une récurrence précocement, on peut intervenir pour ajuster le traitement. C'est ça, la Réunion de concentration pluridisciplinaire. Alors, quand ils ont fait la Réunion, ils ont envoyé la femme au chirurgien.

C'est ça, la lettre qu'on a envoyée au chirurgien. Toujours le respect, chers messieurs. Kindly, c'est la politesse, accepte ces gestes de part, il y a deux enfants vivants.

Des. Brest. Et.

Récente. L'écriture de la médecin artoix. C'est universel.

Il a proposé. Un. Je connais je ne l'ai dit SLNP.

C'est quoi? le traitement du sein, la chirurgie, qu'est-ce qu'on fait? Ils ont soit conservateur, alors ce que je reviens cette femme-là, il peut vous dire non, je veux pas le traitement conservateur. Il y a des femmes qui refusent le traitement conservateur. Surtout surtout dans certaines régions.

Tu vas lui dire, tu vas faire le traitement conservateur mais tu dois venir pour la radiothérapie et si tu fais la mastectomie, tu n'as pas besoin de la radiothérapie dans certaines situations. Cette femme-là, si on fait la mastectomie, elle n'a pas besoin de la radiothérapie. Surtout si elle est N0 et qui est confirmée par la suite.

C'est N0 qu'on a dit tout à l'heure, les onglions, N0, c'est un CN0. On doit attendre le PN0, pathologie, on doit attendre la confirmation à l'hystérologie qu'on croit le croaxiliaire, il n'y a rien. Si il n'y a rien au niveau du croaxiliaire et qu'on a enlevé tout le sein, l'étape de radiothérapie, il saute.

Il n'a pas besoin de radiothérapie. C'est pour ça que certaines femmes te disent si je peux éviter la radiothérapie, je préfère faire la mastectomie. Mais la plupart, bien sûr, elles veulent garder leur sein.

Monsieur, il faut pas rester figé dans les indications. Le standard c'est avec sentinelle biopsie, biopsie du ganglion sentinelle. Et il y a certaines femmes qui te disent non je veux il y en a mais ils sont peu nombreuses.

Mais il faut respecter. Si la femme tu dis je veux pas faire le traitement conservateur, épargner moi je veux plus avoir euh garder le cancer vu certaines euh comment elle pense elle pour le cancer c'est son droit. S'il veut pas faire s'il peut pas faire le conservateur son droit.

Le problème qui se pose chez nous c'est lorsque la mastectomie elle est indiquée et que la femme refuse la mastectomie. Il y en a qui ont un problème. Par contre l'inverse si le traitement conservateur il est indiqué et que la femme veut la mastectomie c'est son choix.

Expliquez-lui c'est son choix. Dans le le le cas là où on est obligé on peut pas faire lorsque la mastectomie il est indiqué on peut pas faire de traitements conservateurs. On n'a pas on peut pas.

Il y a des situations où on peut un petit peu euh faire euh on va parler de ces situations dans les indications. Mais quand on fait un traitement conservateur il faut la radiothérapie. Quand on fait la mastectomie parfois on a on peut ne pas faire la radiothérapie surtout lorsque les gonglions lorsque le N reste zéro et cliniquement et après la biopsie du gonglion sentinelle.

D'accord? Donc on doit faire euh euh euh des sections biopsie c'est ce qu'on est ce qu'il y a fait donc ils ont fait l'envoyer pour la chirurgie première. Alors la chirurgie première on va faire euh une tumeur technique on va pas entrer dans la technique en général on on classe les dessins en fonction du bonnet vous savez c'est quel type de bonnet A B C T E F G H ce que vous voulez A B O C A c'est des petits seins B c'est des seins si vous voulez B c'est des seins moyens quand on on arrive au C c'est des seins un petit peu généreux D c'est volumineux en des petits seins c'est un bonnet c'est un bonnet B on peut le classer bonnet B A bonnet C un grand bonnet B ou bien un petit bonnet C c'est alors euh ce qui fait euh lorsque la taille de la tumeur est avec un petit sein parfois on peut pas faire conserver lorsque c'est des seins plats avec une tumeur de deux centimètres vous n'allez jamais et garder une forme esthétique acceptable du sein après chirurgie donc la taille du sein par rapport à la taille d'une ondule elle intervient également donc on va faire la tumeur ectomée avec euh on doit essayer de passer un salon et on va traiter également le croix axillaire avec le gonglion sentinelle avec le curage du gong on va faire un gonglion sentinelle on vous a un petit peu parlé du gonglion sentinelle alors le gonglion sentinelle c'est pour essayer d'éviter le curage classique le curage classique on enlève beaucoup de tissus au niveau de la région axillaire on enlève beaucoup de tissus et on les voit on n'en a pas pour les étudier pour voir est-ce qu'il y a des gonglions qui sont envahis et lorsqu'on fait cette dissection conventionnelle du croix axillaire le curage conventionnel il y a une grande morbidité qui s'ensuit 70% des femmes après le curage classique gardent des séquelles ça peut être des petites douleurs des paresthésies parfois une gêne au retour lymphatique on a des gros membres ce qu'on appelle des gros bras des gros membres pardon il n'y a pas de traitement des gros membres lorsqu'il y a un problème de retour lymphatique avec un éléphantiasis c'est comme un éléphantiasis au niveau des postes alors le gonglion sentinelle c'est pour essayer justement d'éviter ce curage qui est tellement morbide et qui est souvent inutile dans les formes précoces dans les T1 et même parfois dans les T2 plus de 70% de curage on a des N0 on en fait un curage pour rien alors justement le gonglion sentinelle c'est de chercher chez qui, quelles femmes peuvent dans les 70% des cas où on n'a pas besoin de curage, quelles femmes vont profiter de ce gonglion sentinelle vont avoir on va se passer du curage classique c'est pour éviter

le gonglion sentinelle quel est son intérêt c'est pour éviter un curage conventionnel très morbide là où le but est on se base sur quoi? on se base sur le fait que chaque sein dans les relais gonglionnaires il y a toujours un gonglion qui doit qui est un passage obligatoire pour les autres gonglions il n'y a pas de saut de gonglion il est obligé de passer par ce gonglion là heureusement aussi les études ont montré que lorsqu'on injecte un produit on peut le repérer au niveau du premier relais gonglionnaire de ce sein actuellement c'est une technique qui est validée dans les grands standards de la prise en charge de certaines situations surtout si cette femme là elle est N0 et même à l'échographie c'est des gonglions qui sont non suspects inflammatoires donc cette femme là on ne va pas lui faire un curage parce qu'il n'a pas d'adénopathie très suspecte et même dans les adénopathies très suspectes ce qu'il y a actuellement ce qui a changé dans la prise en charge du cancer du sein sur le plan chirurgical actuellement il y a une désescalade on ne fait plus les mastectomies anciennes les curages anciens on ne les fait plus pourquoi on ne les fait plus? parce que la radiothérapie est tellement performante la chimiothérapie, les traitements médicaux l'hormonothérapie, la thérapie ciblée tellement ça a progressé qu'il y a une désescalade en ce qui concerne la chirurgie la chirurgie maintenant on est de plus en plus conservateur, même pour le croix axillaire on est de plus en plus conservateur et pourquoi on est conservateur? parce qu'on a le gonglion sentinelle on peut le voir, s'il est négatif c'est que tous les autres gonglions sont négatifs ça ne sert à rien de les enlever s'il est positif, là on se discute on rentre dans la spécialité c'est l'ARCP c'est autre chose alors 5 minutes de pause parce que si je continue vous allez dormir pensez à ça et je vais continuer donc 5 minutes de pause on revient à notre cas j'avais caché ces renseignements là avant 38 ans c'est quoi cette CCI? carcinome canalère infiltrant le récepteur hormonal positif HER quoi? équivoque breast conservative surgery gonglion sentinelle sentinelle lymph node biopsy on a fait la conservation, on a fait le gonglion sentinelle alors le gonglion sentinelle il y a différentes méthodes qu'on peut utiliser il y a des méthodes colorimétriques qu'on injecte en colorant on fait une petite incision au niveau axillaire on cherche quelle est la partie qui a été colorée et on la retire il n'est pas très sensible la méthode de référence c'est les isotopes, la radioactivité on injecte du technetium 99 en périclisme oral et on a une sonde qui permet de détecter la radioactivité au niveau du gonglion c'est la méthode de référence la méthode de référence pour le gonglion sentinelle c'est la radioactivité donc il faut qui dans l'hôpital se charge de la radioactivité l'oncologue c'est la radiothérapie thérapeutique, c'est autre chose la radiothérapie diagnostique les isotopes la médecine nucléaire c'est la médecine nucléaire qui doit nous faire le traçage qui peut également participer à la réunion de concertation pluridisciplinaire donc on a vu tout ça voilà la médecine nucléaire ils vont nous envoyer cette image là ils vont injecter en périclisme oral et ils vont repérer l'imagerie en fonction de la radioactivité ils ont des images comme ça voilà l'injection périclisme oral ils ont vu 3 gonglions sentinelles à 2h à 4h je pense à 1h à 2h je ne me rappelle plus mais il y a 3 gonglions qu'on doit aller chercher en peropératoire si on ne retire que ça on n'est pas obligé de faire tout le curage on ne retire que ça et on l'envoie à l'anapath il est marqué, ça ne veut pas dire qu'il est atteint il est marqué parce que c'est ça le gonglion sentinelle, on va chercher est-ce qu'il est atteint ou non ce n'est pas de l'histologie on va essayer de retirer ça et de l'envoyer à

l'anapath comme ça on est sûr si jamais il n'y a pas de cellules tumorales au niveau de ces glandes qu'on a enlevé le reste de la région axillaire après il n'y a rien il a vu ça pour cette même patiente je vais vous montrer après avoir retiré les glandes sentinelles on utilise voilà les glandes qu'on a retirés normalement dans un curage il y a beaucoup de dans un curage conventionnel on enlève beaucoup, on dissèque il faut voir la veine axillaire le pédicule du grand dorsal le pédicule du grand dentelé c'est ça les repères de la région axillaire, il faut vider toute cette région là c'est pour cela qu'on a beaucoup de morbidité après un curage conventionnel là ce qu'on voit ici c'est la sente le détecteur de radioactivité on l'utilise déjà pour l'incision c'est comme le détecteur c'est comme ce stylo là maintenant il y a une technique sans fil on a un écran dans lequel on voit la radioactivité on a la sonde qui permet de chercher les glandes sentinelles et on va au niveau axillaire, on cherche et on entend un bruit en fonction de la radioactivité dès qu'on entend le bruit, on marque là où on l'entend au maximum, c'est là où va être notre incision, c'est une incision de 2 à 3 cm comme ça on dissèque et on va chercher le glande et on va retirer le glande toujours en s'aidant de cette de cette sonde là dans notre cas, elle a été entourée couverte par quoi ? par un gant pour qu'elle reste stérile parce que normalement elle n'est pas stérile, on perd l'opérateur ça doit être stérile on la couvre avec un gant et on travaille avec est-ce que j'ai le son ou non pour entendre la radioactivité il y a la sonde c'est pas une main c'est la sonde qui permet de chercher au niveau des glandes qu'on a retirés est-ce qu'on a retiré les glandes qui sont radioactifs malheureusement j'ai pas le son j'ai pas le son normalement on entend l'activité et on voit dans l'écran voilà l'écran qui montre l'activité ça c'est au niveau du bloc opératoire c'est la technique du glande sentinelle et en fonction de la radioactivité il y a 0, il y a 13, il y a 20 il y a 100 jusqu'à 100 en fonction de la radioactivité on cherche ces glandes là si on avait le son vous allez entendre quand on s'approche de la radioactivité on entend le son voilà le son et c'est les glandes qui ont été retirés pour étudier un empaquet pour savoir est-ce qu'ils sont envahis ou non s'ils sont envahis ça devient un PN PN 1 s'ils ne sont pas envahis ça veut dire PN0 ça veut dire que la tumeur est toujours localisée au niveau du sein et n'a pas encore progressé au niveau des organes de voisinage au niveau loco-régional malheureusement je n'ai pas le son je ne sais pas comment faire le son imaginez que vous avez le son lorsque vous vous approchez du glande et bien sûr on revient lorsqu'on enlève ces glandes là on doit revenir au coaccideur on ne doit plus voir de radioactivité, on ne doit plus entendre le son on est sûr qu'on a enlevé les bons glandes pour ne pas avoir de faux négatifs pour ne pas avoir de faux négatifs on vérifie sur la table comme quoi ils sont radioactifs et on revient au niveau de la tumeur du glande pour voir que la radioactivité qu'on avait avant l'intervention n'est plus présente comme ça on est sûr qu'on a enlevé les glandes et de préférence il n'y a pas un seul glande en sentinelle, en général il y a 2 ou 3 là on a 3 c'est rare qu'on a un seul glande en sentinelle il faut enlever tout ce qui est tout ce qui est chaud, qu'on appelle un glande un glande chaud, c'est à dire qui est radioactif il faut les enlever comme ça lorsqu'on répond à l'anapath la valeur de la réponse dépend de ça s'il te dit toi et moi, tu n'as pas enlevé les bons glandes, ça ne veut rien dire s'il n'y a pas de celles tumorales, toi tu n'as pas enlevé les bons glandes les vrais glandes en

sentinelle tu as un faux négatif le gondulien en sentinelle c'est de minimiser au maximum les faux négatifs en faisant la technique de référence maintenant il y a d'autres techniques à part la radioactivité il y a une technique au verre d'endocyanine il y a un produit un colorant qui s'appelle le verre d'endocyanine qui est fluorescent on l'injecte comme le radioactif sauf que pour le détecter, on éteint la lumière et on utilise une caméra spéciale qui va montrer les gonduliens en sentinelle sous forme de fluorescence on va les enlever on va faire la même chose, voir qu'ils sont fluorescents et qu'il n'y a plus rien comme ça c'est la technique d'avenir. Beaucoup de centres l'utilisent parce que ça permet de court-circuiter le métier nucléaire on a un médecin de moins c'est le chirurgien qui va injecter et qui va trouver son... comme pour le colorant, on n'a pas besoin de médecine nucléaire c'est le médecin qui injecte et c'est lui qui cherche c'est lui qui va chercher c'est pas pour éviter le métier nucléaire c'est surtout pour la stratégie pour le métier nucléaire il faut que la femme vienne la veille de l'intervention pour qu'elle soit injectée pour qu'on montre l'image qu'on a vue tout à l'heure des gonduliens c'est comme une scintigraphie et que le lendemain on fait notre geste là c'est le matin on injecte et on suit la fluorescence en éteignant la lumière et on détecte les gonduliens ça c'est la technique qui est prometteuse qui est d'avenir d'ailleurs à l'hôpital on va essayer d'acheter cet appareil cette caméra avec le colorant au vert d'endocyanine pour essayer de faire beaucoup plus de gonduliens donc ce cas là est arrivé à ce stade le résultat qu'est-ce qu'on attend dans le résultat on a fait la tumorectomie et on a fait le gondulien sentinelle quels sont les différents cas de figure qu'est-ce que le chirurgien doit essayer il doit savoir est-ce que c'est un vrai PNO ou bien est-ce que c'est un PN1 il y a un PNO il y a un PN1 c'est le gondulien sentinelle l'anapath va vous dire est-ce que les gonduliens sont envahis ou non tout simplement tout simplement au niveau de la tumeur, qu'est-ce que le chirurgien cherche les limites d'XRS très important très important le chirurgien ne va pas être satisfait que si l'anathromopathologiste lui dit qu'effectivement vous êtes passé insano, parce que même macroscopiquement vous pouvez avoir l'impression d'être passé en zone saine mais qu'au microscope il vous dit que la tumeur, il y a une limite qui est tumorale donc c'est à l'anapath qu'on a ces renseignements-là les limites d'XRS et l'état des gonduliens est-ce qu'ils sont envahis ou non l'autre chose que je n'ai pas encore dit c'est que le curage axillaire il n'est pas thérapeutique il ne change pas la survie il est essentiellement pour il est essentiellement diagnostique pour voir est-ce que le creux axillaire est envahi ou non ça ne change pas la survie, ça ne change pas le risque de récurrence, ça ne change pas le risque de métastase par la suite ça nous donne un staging, c'est un curage pour le staging c'est pour le stagification pour bien stagifier la tumeur et c'est très important le stade de la tumeur est très important, il faut avoir une idée est-ce que le creux axillaire est envahi ou non le curage ça ne traite pas ça nous donne le stade et le stade il est important pour planifier le reste des événements alors c'est ça ce qu'on attend, alors pour cette femme-là les limites sont saines et les gonduliens à l'anapath finalement on a trouvé 5 gonduliens les peu de choses qu'on a vu tout à l'heure c'est 5 gonduliens, c'est des petits gonduliens qui sont tous non métastatiques donc finalement c'est une tumeur insulin et qui est N0 elle est insulin et elle est PNO donc c'est un bon cancer finalement c'est un bon pronostic parce qu'il est N0 alors est-ce que ça va éviter la radiothérapie il ne va pas éviter la radiothérapie

sur le sein donc l'irradiation du sein elle est obligatoire par contre il va éviter la radiothérapie axillaire j'ajoute encore que la morbidité de la chirurgie elle est encore c'est la même morbidité si on irradie le corps axillaire c'est cette femme-là on va lui éviter on lui a évité déjà le curage axillaire conventionnel avec ses morbidités et on va également lui éviter la radiothérapie au niveau axillaire radiothérapie sur le ici si c'était N+, on devait également irradier le corps axillaire dans ce cas-là on va irradier et le corps axillaire et l'échelle mammaire interne et le cisclope d'autres détails on ne va pas entrer dans les détails elle est N- donc on n'a pas besoin du curage axillaire on va faire la radiothérapie sur le sein avec une surimpression au niveau du lit du moral c'est ce qu'on appelle le boost un boost c'est sur le sur le sein et bien sûr on va attendre on va attendre qu'est-ce qu'il y a cette femme-là, on va faire la chimiothérapie on va faire une chimiothérapie on va faire une thérapie ciblée toujours répondre dois-je faire ce traitement vous devez avoir la liste des traitements qu'il y a et vous vous posez la question chimiothérapie oui ou non oui parce que c'est un déjà le grade SBR qu'on a vu tout à l'heure c'est un SBR 3, c'est un SBR 3 quand c'est un SBR, le résultat vous avez vu il a confirmé le cancer et il a dit en même temps grade 3, le grade 3 c'est-à-dire que on va parler de la classification on n'a pas le SBR c'est un grade 3 il y a grade 1, 2, 3 en fonction du nombre de mitoses, de la différenciation de l'état nucléaire des cellules on n'a pas tout dit, est-ce qu'il est bien différencié moyen différencié ou carrément indifférencié, qui est le stade 3 le stade 1, oui le très bon pronostic le stade 2 et 3, il faut faire la chimio c'est avec un stade 1 mais il y a également un autre élément qui doit nous imposer la chimio, c'est lorsque la tumeur dépasse 2 cm lorsque la tumeur dépasse 2 cm, c'est également on va voir les facteurs pronostiques qui nous posent l'indication de la chimio alors on a vu maintenant on va compléter ce qu'on a vu tout à l'heure donc on va faire la chimiothérapie et en fonction des résultats de l'affiche sachant qu'on avait un HER2 équivoque, s'il est négatif on s'arrête à la chimiothérapie normal, s'il est positif on doit faire une thérapie ciblée concernant l'hormonothérapie toujours la liste est-ce que je fais l'hormonothérapie ? chez elle ? chez cette femme là, est-ce qu'on va faire l'hormonothérapie ? Obligatoire, il est RH+, il est RH+, toujours profiter des éléments qu'on a RH+, le tamoxifène ou bien les anti-aromatases vont améliorer le pronostic chez cette femme là donc on lui donne le maximum de chances la durée du traitement par l'hormonothérapie, c'est par voie orale, c'est décomprimé c'est entre 5 à 10 ans entre 5 à 10 ans c'est prouvé, les études ont montré que ça diminue les risques récidives des métastases.

Alors on a parlé de la thérapie ciblée en fonction du HER, de l'affiche on a parlé de l'hormonothérapie 5 à 6 ans et qu'est-ce qui reste encore comme traitement il reste la surveillance il reste la surveillance alors revenons puisque le chapitre s'intitule adénofibromes du sein pardon, les tumeurs du sein on a vu les diagnostics différentiels on va les revoir pour compléter les informations qu'on a vues tout à l'heure normalement j'ai terminé le cancer du sein j'ai terminé, on a survolé en fonction des cas normalement on est capable de traiter une tumeur, T2, T1 c'est la même prise en charge T3 ou T4 c'est chimiothérapie et le N1 positif alors qu'est-ce que j'ai à dire sur les adénofibromes pour compléter on a dit que ce sont des tumeurs bénignes l'apanage de la femme très jeune, 20-30 ans en général ils sont uniques en général 3 à 4 centimètres, 5 centimètres bien limités fermes sans bien sûr cime cutanée et sans adénopathie,

c'est des tumeurs bénignes l'échographie il est presque pathognomonique ça donne une image épo-échogène ovalaire bien limitée à contourner et à un grand axe parallèle à la peau pourquoi le grand axe est parallèle à la peau parce que l'ondule n'est pas malin c'est pas dur, c'est pas une construction pireuse quand vous posez la centre sur l'ondule, l'ondule va s'étaler comme ça son grand axe va être parallèle à la peau, alors que le cancer non, même si vous posez la centre sur la tumeur cancéreuse il est tellement dur, pireuse que le grand axe va rester en général il reste vertical il n'y a pas de modification postérieure parce que même si il est épo-échogène il est moins épo-échogène que le cancer parce qu'en fonction de l'épo-échogenité on a le renforcement postérieur il est épo-échogène mais quand même ça reste une tumeur qui est ferme qui ne va pas laisser passer beaucoup d'ultrasons alors que le cancer il y a de la nécrose même si c'est dur, il y a de la nécrose qui va laisser, alors qu'on va avoir un renforcement postérieur, là c'est pour comparer vis-à-vis du cancer dans l'adenofibrome il n'y a pas de modification postérieure alors que dans le cancer il y a un renforcement postérieur ce n'est pas un élément très important mais ce qui est le plus important c'est le caractère ovalaire bien limité mobile c'est ça le caractère le plus important dois-je demander une mammographie devant ces éléments-là? 20-30 ans, non. Au-delà de 35 ans, on a peur du cancer dans ce cas-là on peut demander parfois ce que je n'ai pas dit, vous voyez les cancers sont très différents parfois on a une image bien limitée et on a un cancer c'est la forme médulaire du cancer du sein c'est très rare mais on peut parfois avoir un aspect médulaire c'est pour cela qu'il y a un aspect bien limité comme l'adenofibrome mais que c'est la biopsie c'est pour cela qu'au-delà d'un certain âge 40 ans tout l'ondule, même s'il s'agit d'un adenofibrome petit il faut avoir une preuve histologique d'accord? même s'il n'y a pas un cercle homogène, parfois calcifié vous pouvez oublier ça on ne demande pas de mammographie devant si l'âge est important on a un ondule, on a peur de passer à côté du cancer, surtout lorsqu'on ne va pas l'enlever quand on ne va pas l'enlever, il vaut mieux ne pas lâcher la femme dans la nature et demander d'autres imageries, éventuellement une biopsie alors le traitement des adenofibromes, c'est du tumor jusqu'à 3 cm s'il ne dérange pas la femme, on peut la laisser tranquille si elle arrive à 3 cm ou elle la dépasse ça devient gênant pour la patiente ça devient inquiétant pour la patiente dans ce cas-là, il va vous pousser la main à faire une X-rays de cet adenofibrome la remarque que j'ai dit tout à l'heure, parfois quelle que soit la taille d'un ondule au-delà de 40 ans vu le risque du cancer, la fréquence du cancer la gravité du cancer au-delà de 40 ans n'importe quel ondule à part les cystes, n'importe quel ondule plein il faut avoir une preuve histologique traitement médical à oublier, il n'y a pas de traitement médical pour les adenofibromes il n'y a pas de traitement médical il y a beaucoup de médecins qui prescrivent des progestatifs mais l'adenofibrome soit il faut le surveiller soit il faut le réséquer si vous donnez un traitement, c'est surtout un traitement placebo c'est un ondule très petit parfois il est inquiet parfois il ne peut pas accepter le fait que vous allez lui dire, revenez dans 3 mois pour que je fasse l'échographie de contrôle vous lui donnez des pomades à base de progestatifs ça a un effet placebo mais aucune étude n'a montré que le fait de prescrire des progestatifs va diminuer la taille ou va faire égresser les adenofibromes Alors qu'en est-il des cystes? Les cystes définition formation anécogènes de plus de 3 cm un ondule

mammaire image là au lieu d'hypoécogène vous mettez anécogène là c'est une erreur je vais corriger maintenant anécogène il n'y a pas d'écho c'est comme le cancer hypoécogène ou bien l'adenofibrome hypoécogène vous êtes d'accord avec moi? donc image anécogène il n'y a pas d'écho avec un renforcement postérieur puisque elle n'a pas été consommée parmi les traitements s'il est douloureux, s'il gêne la femme on peut les ponctionner en faisant bien sûr attention le cancer du sein s'il y a beaucoup de formes hétérogènes parfois il y a une forme clinique je n'ai pas pu faire ça dans le cours mais ça existe lorsqu'il y a un bourgeon anthraquistique lorsqu'il y a un bourgeon anthraquistique ce n'est plus un Bayeratz 1 ou la 0 ça devient un Bayeratz 4 il faut absolument retirer tout le kyste parce qu'il y a des formes anthraquistiques du cancer ça c'est des raretés le kyste doit absolument être à paroi fine sans aucun contenu à l'intérieur il y a un profil particulier des femmes qui font du kyste je passe rassurée, ponctionnée hygiène de vie, progestérone je n'y crois pas pathologie, sauf s'il y a quelque chose à l'intérieur les tumeurs phyllodes c'est comme les adénophibromes sur le plan clinique et échographique comme tout à l'heure ce sont des tumeurs conjonctives ce ne sont pas des tumeurs épithéliales la principale diagnostic avec l'adénophibrome ce qui les différencie c'est l'évolution rapide ce qui les différencie c'est l'évolution rapide puisque ce ne sont pas des tumeurs épithéliales donc il n'y a pas de lymphophilie les sarcomes ne vont pas aux ganglions les tumeurs conjonctives ne vont pas aux ganglions il y a 3 grades grade 1, grade 2 en général de très bon pronostic le grade 3 c'est considéré comme des sarcomes c'est pour ça que l'adénophibrome les tumeurs phyllodes tout à l'heure je ne voulais pas vous dire que c'est bénin ou bien c'est malin donc dans les grades 1 c'est l'anaparte qui va nous dire c'est l'examen anaparte qui va nous dire est-ce que c'est un grade 1 ou un grade 2 ou un grade 3 en général le grade 1 c'est bénin et le grade 3 c'est des sarcomes c'est des sarcomes ça évolue rapidement parfois le temps d'attendre la consultation on a une grosse tumeur et souvent lorsqu'il s'agit d'un sarcome on fait une mastectomie est-ce qu'on fait le curage pour les sarcomes? c'est des tumeurs conjonctives et toujours l'autre caractéristique des tumeurs phyllodes qui la différencie les adénophibromes ne récidivent jamais les tumeurs phyllodes ils ont ce caractère de récurrence parfois ils étaient grade 1 et ils récidivent sous forme de sarcome c'est pour cela que c'est pas aussi gentil que les adénophibromes les tumeurs phyllodes c'est un peu plus agressif ça n'a pas d'émetteur il y a beaucoup de grade 1 qui sont des tumeurs bénignes mais il faut les surveiller parce qu'il y a un risque de récurrence et parfois ça récidive sous une forme très méchante qui est le sarcome je passe les cancers on a parlé de beaucoup de choses on va compléter ce qu'on sait déjà sur les choses dont on a parlé le plan qu'on a adopté alors quels sont les facteurs de risque? ça on les cherche à l'interrogatoire par exemple la femme de 38 ans qu'on a vu tout à l'heure on a le module, on ne sait pas ce que c'est un qui est-ce que c'est une tumeur bénigne est-ce que c'est une tumeur maligne parmi les choses qui peuvent nous faire pencher vers ça ou ça mais qui ne vont pas changer de toute façon l'attitude c'est de lui demander est-ce qu'il y a un contexte familial est-ce qu'il y a un cancer dans la famille est-ce qu'il y a un terrain d'hyperostrogénie sachant que tous ces éléments parmi les facteurs de risque c'est la durée de l'imprégnation estrogénique alors cette durée elle est augmentée quand? elle est augmentée

quand il y a une puberté précoce à l'âge de 10 ans il est pubert il a été pendant longtemps exposé aux oestrogènes une ménopause tardive même explication l'annuliparité pourquoi il a plus d'hyperostrogènes que l'amiclupar? parce que durant les grossesses il n'y avait que des progestatifs donc il a été épargné durant la grossesse des oestrogènes plus il a des enfants l'autre traitement qui augmente l'imprégnation estrogénique c'est le THS on a parlé dans le traitement d'amenopause traitement d'amenopause quel est son principal risque? c'est le risque de cancer du sein et du cancer de l'endomètre c'est pour cela qu'il faut toujours ajouter des progestatifs c'est la durée d'imprégnation dans les cancers du sein il y a le contexte familial est-ce qu'il est prépondérant? non il n'y a que seulement 5 à 8% de tous les cancers qui sont dus à un problème génétique à une mutation les gènes c'est le BRCA1 et le BRCA2 vous devez les connaître le BRCA1 le BRCA2 syndrome de prédiction familiale 5% des cas mutation du gène BRCA1 ou BRCA2 alors quand il y a une mutation le risque de cancer est très important à 15% des cancers du sein qui sont génétiques la femme va faire 80% des cas au cours de sa vie donc c'est des femmes à très haut risque de faire le cancer si cette femme de 38 ans m'avait dit qu'il y avait une soeur qui a un cancer une mère qui a un cancer et une tante qui a un cancer 3 cas de cancer on va ajouter dans la décision de RCP une ligne qui s'appelle Genetic Assessment évaluation génétique un conseil génétique le conseil génétique le généticien va demander la recherche de la mutation à quoi va servir cette recherche de mutation déjà la fratrie, l'entourage vont savoir qu'ils ont un terrain de cancer du sein ils ne doivent pas attendre 50 ans pour faire le dépistage ils doivent se faire surveiller depuis l'âge de 25 ans consultation, palpation des seins échographie, parfois même lorsqu'on a un doute une IRM à mère donc le cancer génétique qu'est-ce qu'il a de particulier beaucoup de cas dans la famille il survient plus précocement il n'est pas dépistable il faut faire le diagnostic précoce c'est pas comme le cancer sporadique le cancer qui n'est pas génétique on l'appelle cancer sporadique ce sont les plus fréquents heureusement qui se révèlent bien plus tard au-delà de 50 ans c'est pour cela que les cancers sporadiques c'est eux qui ont été pris par les mammographies à partir de 50 ans les cancers génétiques, il faut les chercher bien avant d'ailleurs cette femme-là, elle avait une soeur qui avait un cancer du sein est-ce que je vais dire que c'est un cancer familial je n'ai pas le droit de dire si je dois chercher la mutation s'il y avait plus de trois cas oui, je vais penser à un cancer familial même s'il a un cancer du sein une femme sur huit le hasard peut faire que deux soeurs fassent un cancer alors que ce n'est pas un cancer génétique parce que c'est un cancer qui est très fréquent et peut tomber sur deux soeurs alors qu'il n'est pas génétique mais s'il y a plus de deux soeurs, trois soeurs une mère, une tante surtout dans les parents proches là il faut chercher la mutation j'ai dit à quoi ça sert de rechercher cette mutation, c'est de commencer le dépistage plus préconseillement et parfois proposer des mastectomies prophylactiques et même le BRCA1 et le BRCA2 ça prédispose au cancer du sein et au cancer de l'ovaire, les deux un peu moins l'ovaire mais c'est une prédisposition et le sein et l'ovaire d'ailleurs quand on fait une mastectomie prophylactique parfois on fait carrément une ovariectomie prophylactique à partir d'un certain âge alors tout ce qui est antécédent de dysplasie mammaire, lorsqu'il y a des femmes qui ont des seins très dysplasiques ça il faut les surveiller de près parce que ça peut être la prise en charge elle est

difficile et il bénéficie de beaucoup de biopsies qui peuvent survenir négatives mais il faut les surveiller de près ça reste un facteur nutritionnel l'obésité, pourquoi l'obésité ? l'héperostrogénie c'est également un cancer et dans les statistiques à un certain moment le cancer des seins c'était le cancer des pays développés donc les chiffres que je vous ai dit tout à l'heure 1 sur 1, 1 femme sur 8 1 femme sur 9, c'est surtout les pays développés mais les dernières statistiques qui se font même dans les pays du tiers monde les pays en voie de développement on est en train de se rapprocher des chiffres des pays développés il y a beaucoup de questions à se poser est-ce que le monde des changements des mondes alimentaires on mange beaucoup de viande, on mange beaucoup de graisse, beaucoup de fromage beaucoup de snacks, est-ce que c'est des facteurs qui augmentent ce risque-là ce qui est sûr que maintenant même les pays en voie de développement ils voient une augmentation de l'incidence du cancer du sein là la patte c'est du tumor épithélial les plus fréquents ce sont les adénocarcinomes c'est la biopsie qui va nous dire le type histologique alors adénocarcinome c'est pas suffisant, ce sont des adénocarcinomes bien sûr des carcinomes ça veut dire la même chose à partir des glandes vous voyez la glande vous voyez cette image-là j'aimerais bien la grandir un petit peu vous voyez le canal galactophorique la coupe au niveau du canal, il y a le lobule quand c'est au niveau du canal c'est un canalaire quand c'est au niveau du lobule c'est lobulaire là c'est canalaire ou lobulaire vous voyez un petit peu ça provient d'ici et le canalaire si c'était au niveau j'ai d'autres images je sais pas là c'est un cancer canalaire normalement il y a un épithélium qui est bien fait en principe il y a deux couches il y a une couche qu'on voit ici c'est les glandes, il y a une couche myoépithéliale tous les canaux sont entourés par des cellules musculaires afin de l'histologie de la glande mammaire si vous vous rappelez il y a l'épithélium glandulaire mais sous l'épithélium glandulaire il y a des cellules un petit peu spéciales, c'est comme des muscles c'est eux d'ailleurs qui poussent le lèvre pour l'excrétion et le carcinome c'est surtout au dépôt de ces glandes carcinome canalaire ça peut être non infiltrant ce qu'on appelle les insitus comme ça peut être infiltrant même dans les instituts il y a ceux qui sont canalaires et ceux qui sont lobulaires, donc ils n'ont pas encore dépassé la membrane basale alors pour les infiltrants c'est la même chose il y a les canalaires au niveau du canal il y a les lobulaires et il y a d'autres formes que l'on appelle muscineuses ou bien médulaires d'ailleurs des médulaires en malédiction random ont une forme très bien limitée, même à l'échographie vous avez l'aspect que c'est une tumor bine et c'est la biopsie qui va vous dire que c'est médulaire heureusement qu'en général ces médulaires là et ces muscineuses sont de bons pronostics donc ceci concernant les adénocarcinomes voilà un canalaire invasif le schéma c'est je ne sais pas si vous voyez bien moi je vois bien vous voyez le canal qui est complètement au lieu d'avoir une seule couche c'est multicouche et en plus d'être multicouche il y a des cellules qui dépassent la membrane basale donc ça c'est un canalaire, c'est le canal et qui est invasif là c'est au niveau du lobule, il est lobulaire et il est ça dépasse il est lobulaire, c'est au niveau du lobule et infiltrant dépasse la membrane basale et il y a l'autre qu'est-ce qui manque ici on a le canalaire invasif, on a le lobulaire invasif on n'a pas les cellules ici il y a la même chose qu'ici sauf qu'il n'y a pas de cellules là c'est le lobulaire invasif et le canalaire invasif c'est la même chose qu'ici sauf que ça reste intracanalère, il n'y a pas de dépassement de la membrane basale,

on n'a pas ces cellules là pour schématiser alors là, la maladie de Pagès c'est une forme clinique, on va la voir j'ai montré l'image parce que ça reste dans l'esprit quand vous avez une lésion comme un eczéma du mamelon une lésion eczématiforme du mamelon, surtout quand ça ne répond pas au traitement de l'eczéma qui est le corticoïde ou bien au traitement de quoi ? qu'est-ce qui peut donner une forme eczématiforme ? le psoriasis, les mycoses il ne répond pas au traitement mycosique ni au corticoïde et que ça persiste plus de 3 mois, 4 mois, 5 mois, il faut penser à la maladie de Pagès alors c'est quoi la maladie de Pagès ? c'est un carcinome soit invasif soit in situ qui est sous-jacent et qui est dans cet aspect-là donc il faut faire une imagerie et chercher ce qu'il n'y a pas c'est ça la maladie de Pagès du sein ça va ? lésion eczématiforme du mamelon attention, ça peut être le psoriasis, ça peut être l'eczéma ça peut être une mycose comme ça peut être un cancer, un trancanalère soit in situ soit invasif, sous-jacent parfois on ne trouve rien on trouve rien et on est obligé de faire la mastectomie pour ne pas passer à côté d'un cancer sous-jacent ils sont très fréquents vous faites l'IRM, la mammographie, tout ça vous ne trouvez pas de lésion pourquoi ? parce que quand vous faites la biopsie de cette lésion, elle donne un aspect particulier, il te dit il y a un aspect de grande cellule c'est un Pagès du mamelon cherchez, c'est l'anapath qui nous dit ça une lésion qui ne régresse pas qui ne guérit pas avec les corticoïdes avec les antimicrosiques on est obligé de la biopsie on cherche bien sûr, est-ce qu'il y a un cancer sous-jacent si on ne trouve rien on va biopsier la lésion quand on biopsie la lésion, il va nous dire que c'est une anomalie de ce mamelon, il va nous dire maladie de Pagès, cherchez un cancer sous-jacent, il va nous dire comme ça on va le chercher parfois on ne trouve rien est-ce qu'on va se contenter de ça ou bien d'être radical, ça c'est une discussion heureusement qu'actuellement on peut même si on ne trouve rien ni à la mammographie ni à l'IRM et on a une maladie de Pagès qu'est-ce qu'on fait maintenant on arrive à le faire on résecte toute cette partie-là on fait une grande incision circulaire et on décolle toute la glande on va faire ce qu'on appelle une mastectomie une mastectomie avec conservation de l'étui cutané on va enlever le mamelon la réole et toute la glande on va l'enlever et qu'est-ce qu'on va laisser à la place une prothèse on va laisser en place une prothèse et la femme n'a plus de mamelon on peut la convoquer par la suite quand elle aura guéri sa cicatrisation pour reconstruire on peut faire ça on peut reconstruire un mamelon et on a traité cette femme-là sinon on fait carrément une mastectomie s'il n'y a pas le souci esthétique des femmes très âgées on va faire la mastectomie sachez qu'on peut faire une mastectomie avec avec pamectomie afin de termes, pamectomie plaque aréole mamellonnaire éctomie éctomie c'est réséquer pamectomie c'est réséction de la plaque aréole mamellonnaire avec réséction de toute la glande mamelle et on place une prothèse il y a différents types de prothèses en fonction de la taille, en fonction de la forme en fonction de beaucoup de choses et quand elle aura guéri on pourra construire le mamelon par la suite, on pourra tatouer il y a beaucoup de choses à faire alors après avoir toujours dans le chapitre anapath rappelez-vous de la femme qu'on a vu au début dans son anapath on a vu carcinome infiltratif ductal carcinoma avec avec grade 3 grade 3 le grade c'est le SBR c'est ce grade là SBR 1, 2 ou 3 SBR 1, 2 ou 3 et plus on avance plus c'est méchant c'est en fonction du degré de différenciation bien différencié moyen différencié indifférencié, des

anomalies nucléaires et bien sûr du nombre de mitoses mais pour la conclusion il doit nous dire carcinome invasif canal aérolobulaire ou autre chose avec grade 1, 2 ou 3 on doit voir ça dans l'anapath de la biopsie ou bien de la mastectomie ou bien de la tumorectomie bien sûr toujours dans le chapitre anapath les fameuses récepteurs mono, le KEI67 et l'HER2+, qu'on va demander alors le KEI67 vous le connaissez c'est un marqueur de prolifération il est également exprimé en pourcentage quand il est moins de 14% on dit qu'il est de bon pronostic lorsqu'il dépasse les 14% plus il est élevé, plus c'est agressif mais ça fait partie des choses qu'on demande systématiquement d'ailleurs les 3 tests sont demandés en complément de la biopsie qu'on a fait au début pour nous dire que sinon vous avez rappelé de la lettre tout à l'heure IF malignancy immunohistochimie ou l'immunohistochipage toujours dans le chapitre anapath un peu sur les ganglions l'invasion qu'est-ce qu'il y a comme particulier et les précautions parfois on a un petit tumeur avec ma mère et elle est progressive c'est-à-dire qu'il n'y a pas de saut c'est pour cela qu'on peut faire le ganglion sentinelle elle est précoce le sein est un organe qui est très lymphophile les carcinomes du sein sont très lymphophiles c'est précoce et c'est progressif c'est-à-dire de ganglion en ganglion il n'y a pas de saut c'est le meilleur élément prédictif de la décimation toujours toujours on se pose cette question la décimation est régulière d'où l'intérêt du ganglion sentinelle je vous ai parlé des principes et des éléments c'est le standard maintenant pour les tumeurs T1 et T2 qu'en est-il de l'extension à distance c'est pour dire M0 ou M1 l'examen unique, la mammographie et le TAP et bien sûr la scintigraphie la TDM cérébrale en fonction des signes d'appel ça peut être hépatique pleuropile moniaque ou scieuse neurologique et je passe alors les M+, c'est ce qu'on a sur la chirurgicale lorsque la tumeur est M+, un cancer du sein avec des métastases le raisonnement c'est quoi ce n'est plus une maladie locale ou bien locorégionale c'est une maladie générale c'est une maladie systémique donc déjà le traitement est différent et la radiothérapie c'est un traitement locorégional la radiothérapie c'est un petit peu comme la chirurgie sauf que ça intéresse également le locorégional alors que le traitement systémique, chimiothérapie, hormonothérapie, thérapie civile, tout ça c'est un traitement général le diagnostic les signes de découverte ça peut être à l'autopalpation comme le cas de la femme qu'on a vu tout à l'heure ça peut être une asymétrie du sein, ça peut être un écoulement ça peut être une anomalie du main blanc comme le pajette ça peut être rien 50 ans, on a demandé la mammographie on a trouvé un nodule ou bien des microcalcifications suspectes donc ça peut être rien parfois c'est l'inverse déjà il se présente avec soit une inflammation un T4 quoi soit un T4D déjà avec un T4D soit déjà un M+, soit déjà quelque chose TN mais avec des métastases ça c'est les autres formes qui sont avancées la forme l'ondulaire c'est dont on a parlé tout à l'heure l'interrogatoire, l'inspection, la palpation, les ganglions on a parlé de tout ça l'échographie, l'aspect épo-échogène irrégulier, on la demande surtout chez les femmes jeunes c'est le cas de la femme de tout à l'heure qu'on a vue, 38 ans et l'aspect qu'on a vu tout à l'heure de l'échographie d'ailleurs je l'ai rapporté ici c'est la même image épo-échogène, irrégulière avec atténuation postérieure vous voyez cette cette cette atténuation postérieure c'est pas une atténuation postérieure l'autre avec un renforcement postérieure polyquiste pour les tumeurs épo-échogènes, c'est une atténuation postérieure parce que des ultrasons ont été consommés à

ce niveau là et bien sûr on profite de cette échographie pour aller l'échographie axillaire c'est facile pour les radiologues ils voient l'artère et la veine axillaire à côté il y a les ganglions qui sont bien visibles, lorsqu'il y a un ganglion qui est suspect ils nous disent ça toujours quand je lis l'échographie d'un ondule du sein je vois la tumeur, je décris la tumeur, je dois également voir qu'est-ce qu'ils disent à propos des ganglions pour dire est-ce que c'est un vraiment 1-1-0 ou 1-1-1 alors l'échographie pour les enfants, pour les jeunes femmes la mammographie pour les autres alors à la mammographie vous voyez cette image là spéculée et régulière d'une femme qu'on a vue au service, on cherche ce qu'il y a des micro-classifications parfois elles sont visibles à l'œil nu, parfois il faut faire une loupe pour agrandir pour voir ces micro-classifications alors opacité irrégulière, spéculée avec des micro-classifications, désorganisation architecturale du sein c'est le terme clé c'est le résumé de la sémiologie du cancer du sein la radiologie, résumé spéculé, désorganisation micro-classification c'est des mots clés spéculé, classification, désorganisation c'est des mots clés, on voit bien sûr la peau là on voit qu'il est très bien, par contre là on voit qu'il y a une petite rétraction de la peau ça c'est une mammographie de la femme, on n'a pas fait la mammographie chez elle, c'est une mammographie d'une autre femme, le sein droit le sein gauche, les spéculés la peau, le mamelon, on va le voir le mamelon, vous voyez le mamelon ici mais retenez irrégulier spéculé, micro-classification désorganisation de l'architecture de la glande on confirme avec quoi c'est le trocoute, vous savez maintenant beaucoup de disciplines médicales utilisent ça, le prostate le cerveau le foie le rein, c'est le même procédé, on a des carottes on cherche des carottes on est orienté par l'échographie imagerie donc ça c'est le microbiopsycho-trocoute, le petit A, c'est ça on charge, c'est comme un pistolet, on le charge il y a un ressort, on entre à l'intérieur de la tumeur et on appuie sur un bouton et ça fait un mouvement du ressort qui est entré et qui fait sortir et ce mouvement d'entrée et de sortie va emprisonner du tissu entre ces deux extrémités là et c'est ce qu'on va voir ici c'est ça les carottes vous voyez que les diamètres ne sont pas les mêmes, c'est en fonction du diamètre du trocard qu'on utilise alors ça c'est juste pour vous dire qu'il y a des microbiopsies mais il y a également des macrobiopsies des microbiopsies c'est un appareil spécial qu'on utilise essentiellement lorsqu'on a des micro-calcifications je ne vais pas entrer dans les détails sachez qu'il y a un appareil qui s'appelle le mamoton qui a le même principe que le trocut sauf que le diamètre est plus grand 8 gauges là c'est 11 gauges qui sont les plus épais les 8 gauges ou les 11 gauges pourquoi 11 c'est plus épais que 14 je ne sais pas je vous demande c'est comme les entraînures plus le chiffre augmente plus ils sont fines je ne sais pas sincèrement je ne sais pas pourquoi là on peut voir les millimètres je ne vais pas entrer dans les détails le mamoton c'est plus épais que les microbiopsies le troisième cas de figure c'est la chirurgie quand est-ce qu'on fait biopsie chirurgicale parfois on rate on rate l'ondule parfois on a l'impression qu'on est entré dans l'ondule et l'anapath vous dit que le spécimen que vous avez envoyé on ne trouve rien on ne trouve que de la graisse c'est que vous avez raté votre biopsie ce qu'est-ce qu'on fait normalement il faut la refaire parfois on la rate deux fois trois fois dans ce cas là on est obligé d'aller sur la tumeur et faire une biopsie au niveau de la tumeur c'est les seules indications qui restent de la biopsie chirurgicale c'est les échecs de la micro-biopsie là c'est un autre cas de figure c'est comme un arpent avec quoi on

pêche on pêche des poissons quand est-ce qu'on utilise cet arpent lorsqu'on a on n'a pas d'ondule palpable on a un petit truc qui a été découvert soit à la mammographie soit à l'échographie pour aller le biopsier soit on fait une biopsie stéréotaxique ça existe mais on n'a pas ça soit on demande au radiologue d'aller à travers l'imagerie qui est là, d'injecter cet arpent au niveau de la petite anomalie qui a été vue à l'imagerie et nous à la chirurgie on vient on suit on fait une incision et on suit l'arpent jusqu'à ce niveau là et on retire avec la tumeur comme ça on est sûr qu'on a retiré l'anomalie qui a été arponnée par le radiologue ça c'est les petites lésions il faut faire un guidage c'est là où on fait le guidage on n'a pas de nos yeux palpables on demande au radiologue de nous orienter soit c'est lui qui fait la biopsie de plus en plus c'est les radiologues qui font des biopsies lorsque l'on a des petites lésions mais parfois il fait la biopsie, il voit s'il rate il va nous orienter avec ce tarpon pour aller réséquer plus de tissus, comme ça on est sûr on augmente les chances d'avoir emporté avec nous l'anomalie pour l'étude anatomopathologique ce qui est important c'est la microbiopsie lorsqu'elle est chaude on fait la microbiopsie le mammon-tombe quand on l'utilise lorsqu'on a des microcalcifications ça permet de parfois même d'enlever toutes les microcalcifications c'est rarement utilisé dans notre contexte dans les formes cliniques on a parlé de la forme nodulaire, on va voir les autres formes les formes où on ne touche rien découvertes au dépistage soit on surveille une femme qui est sous traitement hormonal substitutif parce qu'on sait qu'il risque de faire un cancer soit c'est un nodule infracentrémétrique c'est-à-dire on ne palpe rien mais on fait l'échographie on trouve un nodule de 7-8 mm vous savez un nodule de 7-8 mm chez une femme qui a des seins bonnet B bonnet C, vous pouvez ne pas le palper, surtout s'il est profond d'accord, il est infraclinique infracentrémétrique lorsqu'il n'y a que des microcalcifications il n'y a pas de nodule ça c'est des formes infracliniques alors toutes ces situations-là on peut trouver de l'institut comment on peut trouver de l'invasif ça ne veut rien dire le fait d'avoir des microcalcifications on va trouver une lésion qui n'est pas invasive, ça ne veut rien dire parfois même des microcalcifications et l'anapath vous dit que c'est un cancer sinon invasif d'accord ? c'est ce que je voulais dire par infiltrant ou institut, ça peut être infiltrant ça peut être un institut bien sûr il a de la chance s'il n'est que de l'institut il faut aller risquer le reste ce qui reste il a moins de chance mais de bons pronostics quand même s'il est invasif en rouge très bon pronostic, quand la tumeur est petite en général c'est de très bons pronostics même s'il est invasif parfois on ne fait que de l'archéologie dans certains cas on va voir quels sont les cas où on ne fait que de l'archéologie lésion de 7 mm, 8 mm RH+, femmes au delà de 40 ans SBR1 HER2 négative pas d'emballe vasculaire pas de métastase pas d'adénopathie, dans ces cas là parfois on ne fait que de l'archéologie mais bien sûr on fait le RCP et on doit avoir tous ces éléments là pour ne rien ajouter mais ça reste quand même des cas très rares ils sont de très bons pronostics et la guérison est à son poste alors à l'inverse des formes inflammatoires qui sont de très bons pronostics les formes inflammatoires c'est du sein rouge avec le cancer tellement c'est rouge, un grand pouvoir métastatique les cellules sont très libres ça circule dans la circulation elles peuvent s'implanter au niveau de n'importe quel organe et donner des métastases en général en 50 ans d'une biopsie d'une microbiopsie pour commencer le traitement local les seins inflammatoires c'est comme les seins

métastatiques qui dit inflammation, dit métastase seins inflammatoires presque égales à 100 souvent si on cherche bien on trouve des métastases ils sont de très mauvais pronostics T4D c'est le dernier de la liste ce sont les derniers, les T4D alors femme évoluée méconnue, négligée grosse tumeur parce que pour arriver à une tumeur de téralois, c'est à dire plus de 5 centimètres pour arriver à une tumeur de 6 centimètres ou bien 7 centimètres, ça veut dire que la femme elle savait qu'elle avait un ondule mais qu'elle l'a négligée on ne peut pas révéler un cancer du sein ne se révèle pas par une tumeur de téralois ou de T4 surtout de téralois ça veut dire qu'elle avait un ondule elle a fait des traitements elle est allée voir le vrai, je ne sais pas et c'est un truc qui a été négligé l'évolution naturelle, à part le fait de donner des métastases, ça peut donner des ulcérations, ça s'ulcère ça s'infecte, ça devient bourgeonnant ça devient ulcéro-bourgeonnant dans ce cas là c'est de très mauvais pronostics mais bien sûr sans perdre du temps il faut biopsier rapidement et démarrer le traitement afin d'essayer de rattraper les choses mais grosso modo vis à vis, par rapport aux formes cliniques petites, sans ulcérations sans avoir atteint le T4, le T3 ils n'ont pas un bon pronostic comme les autres tumeurs. Ça peut être associé à la grossesse on pensait que la grossesse allait aggraver le pronostic vu que il y a beaucoup d'hormones au cours de la grossesse mais les études montrent qu'il n'y a pas de différence également l'autre chose c'est la radiothérapie et la chimiothérapie parfois on attend la fin de la grossesse pour faire la chimiothérapie est-ce que ça retarde, est-ce que ça engage est-ce que ça change le pronostic même avec la grossesse il y a des formes avec la grossesse, c'est-à-dire une femme enceinte peut faire un cancer il faut discuter convenablement, il y a beaucoup de choses à faire et ça ne change pas le pronostic par rapport aux autres cas de figure il y a des formes bilatérales il y a des formes chez l'homme, parfois on peut trouver le cancer de l'homme ils sont très bons pronostics alors les diagnostics différentiels on a vu ça les adénophibromes, les tumeurs philodéliques les formes inflammatoires rarement, parfois il peut s'agir d'une tuberculose inflammatoire ou bien d'une mastite granulomateuse il y a une forme d'inflammation du sein qui s'appelle la mastite granulomateuse qui ressemble au cancer, sauf que à la biopsie, au lieu de répondre au cancer inflammatoire, il répond mastite granulomateuse et souvent il nous dit il faut chercher une tuberculose, une sarcoïdose une lèpre il faut faire un complément de bilan pour avoir un diagnostic c'est des maladies granulomateuses le bilan des préventions, le TAP la clinique, la mammographie on fait de moins en moins de radiothorax parce qu'on fait le TAP on fait de moins en moins d'échographie parce qu'on fait le TAP la scintigraphie s'il y a des signes d'appel aux oeufs ou bien dans les tumeurs très évoluées les T3 et T4 je ne voulais pas entrer dans les détails c'est à l'hôpital d'extension invasion au breast invasion au poumon invasion au foie ou invasion au lorçado les principaux et bien sûr au cerveau breast cancer has spread to other parts of the body c'est ça l'objectif du bilan d'extension la classification je vous y dis ce qu'il faut chercher les T1, T2, T3, T4 et les N0, les N1 M0 les T1, T2, T3, T4 les détails oubliés à votre stade c'est pas l'appel de retenir ça les T1, les T2 les T3, les T4 T4A, T4B, T4C T4D ça va ? pour les N c'est clinique N0, N1 on attend le P pour dire c'est plus ou moins N0, N1 même le stade vous oubliez le stade, n'entrez pas dans les détails retenez ce que je vous y dis alors les facteurs qui influencent le pronostic et qui influencent également le traitement la taille bien sûr on a vu le T

l'emballement cutané qui est le T4B ou la paroi qui est le T4 quoi ? la paroi c'est quoi ? T4A la paroi est plus gentille que la peau ou bien carrément métastase, c'est très bon pronostic bien sûr le principal le principal facteur pronostic c'est l'atteinte ganglionnaire qu'on cherche actuellement dans beaucoup de cas avec le ganglion sentinelle le grade histologique SBR Scarfe, Blum et Richardson 1. Bon pronostic 2. Moyen 3. Mauvais pronostic pour être binaire les bons pronostics sont les 1 les 2 et 3 sont les mauvais pronostics d'accord ? bien sûr, à l'anapathie s'il y a des embouts vasculaires ça prédit le risque de métastase le récepteur mono qu'est-ce qu'il y a de bon pronostic ? positif ou négatif ? positif là, pardon j'ai empiété sur l'autre cours j'ai oublié la montre donc on continuera sur ces diapositifs la prochaine fois d'accord ? je vous remercie